

中医药治疗慢性肠炎的方法和临床效果探讨

王崇坚

(云南省保山市昌宁县中医医院 云南 保山 678100)

摘要: 目的: 分析中医药治疗慢性肠炎的临床效果。方法: 86 例慢性肠炎患者, 根据信封随机法分为常规组与实验组, 各 43 例。常规组给予参苓白术散治疗, 实验组给予自拟肠炎康方灌肠治疗。对比两组治疗效果。结果: 实验组与常规组的治疗总有效率分别为 93.02% 与 79.07%, 疾病复发率分别为 2.33% 与 37.21%, 实验组治疗总有效率明显高于常规组, 疾病复发率明显低于常规组, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。结论: 对慢性肠炎患者采用自拟肠炎康方 + 肠炎康灌肠方 + 针灸进行治疗的疗效显著, 疾病复发率低, 可明显改善患者各项临床症状, 值得实践推广。

关键词: 慢性肠炎; 中医药; 临床效果

中图分类号: R758.63 文献标识码: B 文章编号: 1006-0979(2017)04-0090-01

慢性肠炎指的是慢性肠道炎症性疾病, 近些年来, 该类疾病的发病率呈现逐年递增的状态。分析该类疾病的具体发病机制包括霉菌、细菌、病菌等感染引发, 同时还有可能是变态反应引发^[1], 以腹泻、腹痛、大便次数增多等作为主要的临床症状, 具有较长的发病周期, 通常病情超过 3 个月。随着近些年来中医药在临床上的广泛推广, 逐渐应用于各类疾病的临床治疗中, 并取得了较为显著的治疗效果。本次研究将中医药应用于慢性肠炎患者的疾病治疗中, 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料: 选择本院 2015 年 1 月 ~ 2016 年 5 月收治的 86 例慢性肠炎患者作为本次研究对象, 所有患者均经过临床常规诊断后显示疾病被确诊, 均在知情同意的前提下纳入本次实验。根据信封随机法分为常规组与实验组, 各 43 例。常规组男 24 例, 女 19 例, 年龄 22 ~ 68 岁, 平均年龄 (45.17 ± 3.41) 岁, 病程 4 个月 ~ 6.5 年, 平均病程 (3.42 ± 0.53) 年; 实验组男 25 例, 女 18 例, 年龄 21 ~ 67 岁, 平均年龄 (45.17 ± 3.29) 岁, 病程 4 个月 ~ 7 年, 平均病程 (3.50 ± 0.57) 年。两组患者一般资料比较, 差异无统计学意义 ($P > 0.05$), 具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 常规组: 给予参苓白术散进行治疗。药方组成: 党参 20g, 茯苓 15g, 薏仁 20g, 白术 15g, 白扁豆 15g, 砂仁 10g, 莲子肉 15g, 桔梗 9g, 甘草 6g。将上述中药材以水煎服, 每日服用 1 剂, 分为早晚 2 次服用, 10d 为 1 个疗程, 共治疗 3 ~ 4 个疗程, 并在治疗完成后采取肠镜复查。

1.2.2 实验组: 采用自拟肠炎康方灌肠治疗。药物组成: 赤芍 10g, 当归 12g, 炙黄芪 12g, 地榆炭 15g, 白花蛇舌草 15g, 半枝莲 15g, 炙甘草 10g, 丹皮 10g, 白败酱草 15g, 乌药 6g, 桑螵蛸 10g, 每日 1 剂, 分为早、晚 2 次服用; 给予肠炎康灌肠方进行治疗: 药物组成: 赤芍 10g, 当归 10g, 地榆炭 15g, 茜草 10g, 白花蛇舌草 15g, 败酱草 15g, 生甘草 10g, 米壳 6g, 白芨 6g, 每晚 1 次保留灌肠; 针灸: 选择肠门穴、天枢穴、天皇副穴进行针灸, 1 次/d, 留针时间为 30min。

1.3 疗效判定标准: 治愈: 临床症状完全消失, 给予肠镜检查后无异常情况; 显效: 临床症状明显改善, 给予肠镜检查后基本修复肠黏膜; 有效: 临床症状有所改善, 肠镜检查后部分肠黏膜修复; 无效: 病情无改善甚至加剧^[2]。总有效率 = (治愈 + 显效 + 有效) / 总例数 × 100%。

1.4 统计学方法: 采用 SPSS20.0 统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数 ± 标准差 ($\bar{x} \pm s$) 表示, 采用 t 检验; 计数资料以率 (%) 表示, 采用 χ^2 检验。 $P < 0.05$ 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 临床疗效: 实验组治疗总有效率明显高于常规组, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。见表 1。

表 1 两组临床治疗效果比较 [n (%), %]

组别	n	治愈	显效	有效	无效	总有效率
实验组	43	31 (72.09)	4 (9.30)	5 (11.63)	3 (6.98)	93.02 ^a
常规组	43	22 (51.16)	5 (11.63)	7 (16.28)	9 (20.93)	79.07

注: 与常规组比较, ^a $P < 0.05$

2.2 疾病复发率: 治疗后对两组患者均进行为期 6 个月的病情随访, 实验组治疗后的疾病复发率为 2.33%, 常规组为 37.21%, 比较差异

有统计学意义 ($P < 0.05$)。见表 2。

表 2 两组治疗后的疾病复发率比较 (n, %)

组别	n	复发例数	复发率
实验组	43	1	2.33 ^a
常规组	43	16	37.21

注: 与常规组比较, ^a $P < 0.05$

3 讨论

慢性肠炎在临床上较为常见, 近些年来该类疾病的发病率呈现逐年递增的趋势, 分析慢性肠炎的主要临床症状包括持续性的腹部疼痛感、肠鸣音、腹胀、增多大便次数、大便性状为稀状等, 且带有黏液。中医理论认为, 慢性肠炎属于读写、泄泻的范畴, 以大小肠、脾胃等作为主要的病变部位, 同时与肾、肝等脏器的联系十分紧密。当人体情志失调、精神紧张、肝气郁滞等情况时将容易引发脾虚湿盛、代谢失常等, 并引发慢性肠炎病变。该类疾病具有病情复杂、病程漫长等特点, 应及时进行临床干预, 帮助患者促进疾病的早日康复, 改善生存质量。

中医理论治疗方案主要以整体出发, 及时调整患者各个脏腑的功能, 帮助其达到“阴阳平衡”的效果。肠炎康方口服药物的作用在于帮助患者调理气血。补虚解毒、调理机体整体病理状态, 帮助患者机体免疫能力得到有效的增强, 促进疾病的早日康复。药方中的当归、炙黄芪、赤芍等可达到补气健脾、养血生血的疗效; 炙甘草可达到调理脾胃、调和诸药的效果。现代临床表明, 甘草具有良好的类激素效果, 可帮助患者有效缓解肠黏膜充血水肿状态; 半枝莲、丹皮、白花蛇舌草、败酱草可达到清热解毒的效果。该类药物具有抑制免疫与变态反应的效果, 利于减少炎性因子的渗出, 可减轻对人体肠黏膜造成的损伤并进行修复; 地榆炭、茜草可达到涩肠止血的效果, 并配合赤芍、当归、茜草、白花蛇舌草、地榆炭、败酱草、生甘草、白芨等可达到局部活血、去腐生肌的疗效。将口服药物与灌肠药物相互结合治疗, 可进一步提高临床疗效, 达到补虚、活血、解毒、祛腐的效果。另外, 再配合肠门穴、天枢穴、天皇副穴可进一步缩短病程, 降低疾病复发率^[3,4]。

本次研究, 常规组与实验组患者分别采取参苓白术散与自拟肠炎康方 + 肠炎康灌肠方 + 针灸进行治疗, 结果显示, 实验组患者治疗总有效率为 93.02%, 明显高于常规组, 实验组复发率为 2.33%, 明显低于常规组, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。

综上所述, 对慢性肠炎患者采用自拟肠炎康方 + 肠炎康灌肠方 + 针灸进行治疗的疗效显著, 疾病复发率低, 可明显改善患者各项临床症状, 值得实践推广。

参考文献

- [1] 黄家兴. 参苓白术散合补中益气汤配合灌肠方治疗慢性溃疡性结肠炎的疗效观察 [J]. 中国老年保健医学, 2012, 10(1): 38-39.
- [2] 潘波, 曹乾榕. 青紫合剂保留灌肠治疗慢性肠炎 286 例临床体会 [J]. 中国民族民间医药, 2016, 25(6): 112-112.
- [3] 谢飞, 李五生, 金宗英等. 加减小头翁汤剂灌肠治疗慢性肠炎的临床观察 [J]. 成都医学院学报, 2016, 11(1): 96-97, 102.
- [4] 安雪峰, 赵继国, 任茜. 中医辨证分型治疗慢性结肠炎 82 例 [J]. 四川中医, 2005, 23(9): 63-64.

2017 年 1 月 6 日收稿